Caso 9. Adolescente con problemas de peso: análisis DAFO y líneas de actuación

Organización y Gestión del Centro

Javier Gómez López

3 de noviembre de 2026

Enunciado de la tarea

A partir del caso *Adolescente con problemas de peso*:

1. Analizar el caso y elaborar un análisis DAFO.
2. Proponer líneas de actuación que aporten soluciones para mejorar la situación de la adolescente en el centro educativo.
3. Ordenar las actuaciones por su grado de urgencia e importancia.
4. Clasificar las actuaciones según los órganos, departamentos o personal del centro responsables de ellas.

1. Análisis del caso

1.1. Datos relevantes

Situación sanitaria
Mujer de 20 años (adolescencia tardía) que acude al centro de salud con su madre por delgadez, falta de apetito y comidas a deshoras. Peso de 48 kg, talla de 160 cm e IMC de 18,75, en el límite inferior de la normalidad (18,5). Presenta palidez cutánea y el resto de la exploración es normal. No toma medicación. Además, la madre solicita una serología de VIH.

Conductas de riesgo
Se marchó de casa tres días con una amiga consumidora de drogas y alcohol, después de robar a su padre 60.000 € que el grupo gastó en ese tiempo (entre otras cosas, en un coche). Según la madre, hay riesgo de accidentes, de consumo de drogas y alcohol, de embarazo y de delincuencia. Solo lo contó después de mucha insistencia.

Situación escolar
Solo ha cursado hasta 2.º de ESO y no tiene el título de Graduado en ESO. Hace dos años que dejó el instituto porque, en sus palabras, *«no le interesaba nada de lo que se podía aprender allí»*. Es un caso de abandono escolar temprano. Como ya ha superado la edad de la enseñanza obligatoria, hoy está fuera del sistema educativo.

Contexto familiar (genograma)
El padre tiene 43 años, estudios de EGB y trabaja como camionero. El genograma lo señala como alcohólico, con esguince cervical y lumbalgia, y la relación con su hija aparece como distante.

La madre tiene 41 años, estudios universitarios y es profesora; el genograma recoge la anotación «DP» (previsiblemente, depresión). Las relaciones de la madre con el padre y con la hija se representan como conflictivas. No constan hermanos.

1.2. Interpretación desde el centro educativo

El problema que motiva la consulta es el bajo peso, pero desde el punto de vista educativo es un síntoma más de una situación de **riesgo psicosocial múltiple**. Coinciden aquí la desvinculación escolar, los hábitos de salud inadecuados, el consumo de sustancias en el grupo de iguales, las conductas antisociales y un entorno familiar con alcoholismo, posible patología depresiva y relaciones conflictivas.

Que tenga **20 años** cambia el planteamiento de la intervención:

- **El centro de referencia ya no es el instituto ordinario.** Es un **centro de educación de personas adultas** (CEPA), o un IES que ofrezca educación de adultos, al que puede incorporarse porque ya tiene 18 años (art. 67.1 LOMLOE). Ahí puede cursar la Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA), presentarse a las pruebas libres para obtener el título de la ESO (art. 68.2) o acceder a un ciclo formativo de grado básico para adultos (art. 68.3). La LOMLOE incluye además entre los objetivos de la educación de adultos «promover la salud y los hábitos saludables de alimentación» (art. 66.3.i).
- **No hay absentismo ni protección de menores.** Su vuelta a la formación es **voluntaria**: no se puede obligar, hay que motivarla. Por eso la acogida y el vínculo inicial son decisivos.
- **Ella decide sobre sí misma.** Es mayor de edad: la información sanitaria y la implicación de la familia en el centro requieren **su consentimiento**. La madre deja de ser la interlocutora formal, aunque sigue siendo un apoyo muy valioso.
- **Las consecuencias de sus actos son de adulta.** Un robo o un delito ya no se tratan por la vía de menores, lo que hace más urgente intervenir antes de que se cronifique la situación.

Por tanto, el análisis se sitúa en el **centro de adultos donde la joven se matricula**. En este caso, la derivación puede venir del propio centro de salud o de su madre.

2. Análisis DAFO

Los factores internos son los de la propia joven y el centro de adultos. Los externos, los de la familia, el grupo de iguales y los recursos del entorno.

Debilidades (internas)

- Desmotivación hacia lo escolar y dos años desconectada de cualquier formación.
- Sin título de la ESO y con un nivel formativo bajo (2.º de ESO).
- Bajo peso, inapetencia, comidas desordenadas y palidez: posible riesgo de trastorno de la conducta alimentaria o de malnutrición asociada al consumo.
- Conductas de riesgo: fuga, robo, posible consumo de alcohol y drogas, y relaciones sexuales de riesgo (VIH, embarazo).
- Baja percepción del riesgo y comunicación difícil con los adultos.
- Centro: alto riesgo de que la deje pronto. El alumnado adulto se da de baja con facilidad si no se siente acogido.

Amenazas (externas)

- Al no ser obligatoria la escolarización, ningún mecanismo la hace volver si ella no quiere.
- Padre con alcoholismo y relación distante con la hija; relaciones conflictivas en la familia; posible depresión materna.
- Grupo de iguales consumidor de drogas y alcohol, con acceso a dinero.
- Consecuencias penales como adulta, riesgo de accidentes, de embarazo no deseado y de infecciones de transmisión sexual.
- Con 20 años y sin título de la ESO, riesgo de exclusión laboral y de empleo precario.

Fortalezas (internas)

- Buen estado físico general: consciente, orientada, colaboradora, exploración normal y sin medicación.
- Acude a consulta y acaba contando lo ocurrido: hay margen para el vínculo y la comunicación.
- Mayoría de edad: puede decidir y elegir su itinerario (ESPA, pruebas libres, FP), que puede tener una orientación profesional.
- Su desinterés apunta a una oferta que no conecta con ella, no necesariamente a una falta de capacidad.
- Centro de adultos: horarios flexibles, modalidades presencial y a distancia (art. 70 bis), grupos reducidos y enseñanza organizada por ámbitos.

Oportunidades (externas)

- Madre muy implicada y preocupada; además es profesora y conoce el sistema educativo.
- Atención primaria ya implicada: puede derivarla al centro de adultos y coordinarse con él.
- Recursos externos: servicios sociales, centros de atención a las adicciones, salud mental y servicios públicos de empleo.
- Marco LOMLOE: acceso a la educación de adultos (art. 67.1), salud y alimentación (66.3.i), orientación profesional junto con empleo (67.10), pruebas libres de la ESO (68.2), grado básico para adultos (68.3) y prueba de acceso a FP de grado medio (art. 41).

Estrategias que se derivan del DAFO

- **Fortalezas + Oportunidades (ofensivas).** Aprovechar su buena disposición en consulta y la derivación desde el centro de salud para que se matricule en un itinerario que ella misma elija.
- **Fortalezas + Amenazas (defensivas).** Usar la tutoría y la flexibilidad del centro de adultos para ofrecerle un adulto de referencia y un grupo alternativo al grupo consumidor.
- **Debilidades + Oportunidades (reorientación).** Compensar la desmotivación con una formación práctica orientada al empleo y aprovechar los recursos sanitarios para el proble-

ma de peso y de consumo.

- **Debilidades + Amenazas (supervivencia).** Hacer una acogida inmediata y un seguimiento estrecho para evitar que lo deje, y derivarla con su consentimiento a servicios sanitarios y sociales.

3. Líneas de actuación ordenadas por urgencia e importancia

Las actuaciones se clasifican con la matriz *urgente–importante* en tres niveles de prioridad:

- **P1. Inmediata**: urgente e importante, entre la matrícula y las primeras semanas.
- **P2. Corto plazo**: importante y con plazo, durante el primer trimestre y después de forma continuada.
- **P3. Medio plazo**: importante pero no urgente, durante el curso y en los documentos del centro.

Nº	Actuación	Prioridad	Responsable principal
P1 — Inmediata (urgente e importante)			
A1	**Acoger e informar.** Atender la derivación del centro de salud o de la madre, hacer una entrevista de acogida individual, explicarle las opciones (ESPA presencial o a distancia, pruebas libres de la ESO, grado básico para adultos, prueba de acceso a grado medio) y facilitarle la matrícula en cualquier momento del curso.	P1	Jefatura de estudios; Orientador/a; Secretaría
A2	**Hacer una valoración inicial y una entrevista de orientación.** Valorar su nivel de competencia para situarla en el nivel y los módulos que le correspondan, y hacer una entrevista confidencial sobre sus intereses, su estado emocional, la autoestima y la relación con la comida.	P1	Orientador/a; Equipo docente (ámbitos)
A3	**Coordinarse con los servicios sanitarios y sociales, con su consentimiento.** Coordinarse con atención primaria por el bajo peso y la salud sexual, ofrecerle la derivación a recursos de adicciones, salud mental o servicios sociales y, si aparecen indicios de violencia o explotación, aplicar el protocolo del centro.	P1	Dirección; Orientador/a; Coordinador/a de bienestar y protección (art. 124.5)
A4	**Asignar un tutor o tutora de referencia y firmar un compromiso.** Un adulto de referencia y un compromiso personal firmado por ella, con objetivos a corto plazo alcanzables.	P1	Jefatura de estudios; Tutor/a
P2 — Corto plazo (importante, con plazo)			
A5	**Diseñar un itinerario formativo personalizado.** Combinar la ESPA (o la preparación de las pruebas libres) con un objetivo profesional concreto: la prueba de acceso a FP de grado medio, un ciclo de grado básico o la orientación al empleo junto con los servicios públicos de empleo (art. 67.10).	P2	Orientador/a; Tutor/a; Jefatura de estudios

Nº	Actuación	Prioridad	Responsable principal
A6	**Adaptar la metodología a una persona adulta.** Aprendizaje funcional y ligado a la vida real, proyectos relacionados con sus intereses y una evaluación ajustada a su punto de partida. Si lo necesita, compaginarlo con la modalidad a distancia (art. 70 bis).	P2	Equipo docente; Departamentos de ámbito
A7	**Hacer un seguimiento para que no lo deje.** Registro de asistencia, contacto inmediato si falta varios días seguidos, tutorías individuales periódicas y reuniones del equipo docente para ajustar la respuesta.	P2	Tutor/a; Equipo docente; Jefatura de estudios
A8	**Implicar a la familia, solo si ella lo autoriza.** Con su autorización, entrevistas con la madre para coordinar el apoyo en casa, mediación en el conflicto madre–hija y orientación de la familia hacia recursos de terapia familiar o de alcoholismo.	P2	Tutor/a; Orientador/a
P3 — Medio plazo (importante, no urgente)			
A9	**Desarrollar educación para la salud.** Talleres de alimentación saludable e imagen corporal, prevención de adicciones y educación afectivo-sexual (VIH, embarazo), integrados en los ámbitos y en la tutoría, en línea con el art. 66.3.i.	P3	Orientador/a; Tutores; Departamento del ámbito científico-tecnológico; CCP
A10	**Crear vínculos positivos con el centro.** Actividades culturales, deportivas y de participación, enseñanzas para el desarrollo personal y aprendizaje cooperativo, para ofrecerle un grupo alternativo.	P3	Jefatura de estudios; Responsable de actividades complementarias
A11	**Revisar los documentos del centro y formar al profesorado.** Incorporar al proyecto educativo, a la PGA y al plan de acción tutorial protocolos de acogida, de prevención del abandono y de detección de trastornos de la conducta alimentaria y consumo en jóvenes adultos, y ofrecer formación al claustro sobre estas señales de alerta.	P3	Equipo directivo; Claustro; CCP; Consejo Escolar
A12	**Establecer convenios con entidades externas.** Colaboración estable con el centro de salud, los servicios sociales, los recursos de adicciones, los servicios de empleo y ONG (art. 127.j) para derivar en ambos sentidos.	P3	Consejo Escolar (fija las directrices); Dirección (las ejecuta)

Criterio de ordenación. Primero se asegura que la joven *llegue y se quede* en el centro y que sus necesidades de salud estén atendidas (A1–A4). En la educación de adultos la primera semana decide si continúa, y sin vínculo no hay intervención posible. Después se construye un itinerario con sentido para ella y se evita que lo deje (A5–A8). Por último, se actúa sobre la organización para responder mejor a otros casos (A9–A12). Al ser mayor de edad, rigen siempre su **autonomía y su consentimiento**: la información sanitaria y familiar solo se comparte si ella lo autoriza y con quien la necesita para intervenir.

4. Clasificación por órganos y personal responsables

Los órganos de gobierno (Consejo Escolar, Claustro y equipo directivo) son los que recoge la LOMLOE (arts. 119 y 126–132). Los órganos de coordinación docente (orientación, departamentos, CCP, tutoría y equipo docente) son los que la ley menciona en su art. 119. En los centros de adultos los desarrolla la normativa autonómica de forma análoga al Reglamento Orgánico de los IES[1], con departamentos organizados por ámbitos.

Órgano / personal	Funciones en este caso	Actuaciones
Órganos colegiados de gobierno		
Consejo Escolar	Propone medidas de estilos de vida saludable y de convivencia (art. 127.g), fija las directrices de colaboración con entidades (127.j), aprueba el proyecto educativo y evalúa la PGA (127.a–b).	A11, A12
Claustro del profesorado	Aprueba los aspectos educativos de los planes (acción tutorial, acogida) y propone la formación del profesorado.	A11
Órganos unipersonales (equipo directivo, art. 131)		
Dirección	Garantiza el cumplimiento de la normativa (art. 132.d), impulsa la colaboración con las familias y con otras instituciones (132.g) y coordina la derivación a servicios externos.	A3, A11, A12
Jefatura de estudios	Organiza la acogida, la asignación de grupo y tutor, el seguimiento de la asistencia y las actividades.	A1, A4, A5, A7, A10
Secretaría	Gestiona la matrícula (también fuera de plazo, si la normativa lo permite) y las inscripciones en pruebas libres, y custodia el expediente de forma confidencial.	A1
Coordinador/a de bienestar y protección	Aplica el protocolo si aparecen indicios de violencia o explotación (art. 124.5).	A3
Órganos de coordinación docente		
Orientación (departamento u orientador/a del centro)	Hace la entrevista de acogida, la orientación académico-profesional, la coordinación con los servicios sanitarios, sociales y de empleo y la intervención familiar consentida.	A1, A2, A3, A5, A8, A9
Comisión de coordinación pedagógica (CCP)	Integra la educación para la salud en las programaciones y revisa los documentos institucionales.	A9, A11
Departamentos de ámbito (comunicación, social, científico-tecnológico)	Hacen la valoración inicial y la adaptación metodológica, y desarrollan contenidos de salud y alimentación en el ámbito científico-tecnológico.	A2, A6, A9
Responsable de actividades complementarias	Organiza actividades que favorecen la integración y un ocio saludable.	A10
Tutor/a	Es la persona de referencia: hace el compromiso, las tutorías individuales, el seguimiento de la asistencia y, si ella lo autoriza, el contacto con la familia.	A4, A5, A7, A8, A9
Equipo docente	Aplica de forma coherente la adaptación metodológica y participa en el seguimiento.	A2, A6, A7

[1] Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

5. Conclusión

El bajo peso de esta joven de 20 años es la parte visible de un problema más amplio: abandono escolar sin título, conductas de riesgo y un entorno familiar frágil. Como ya es adulta, el sistema educativo no puede obligarla a volver; solo puede **atraerla y retenerla**. Por eso el centro de adultos tiene que ofrecerle una acogida cálida y un itinerario con sentido profesional, y actuar de forma coordinada: la jefatura de estudios y la tutoría acogen y hacen el seguimiento, la orientación evalúa, orienta y conecta con los servicios sanitarios, sociales y de empleo, el equipo docente adapta la enseñanza a una persona adulta, y el equipo directivo, el Claustro y el Consejo Escolar convierten la experiencia en protocolos estables. Todo ello respetando su autonomía como mayor de edad. La clave es que, mientras siga vinculada a una formación, sigue habiendo margen para intervenir.